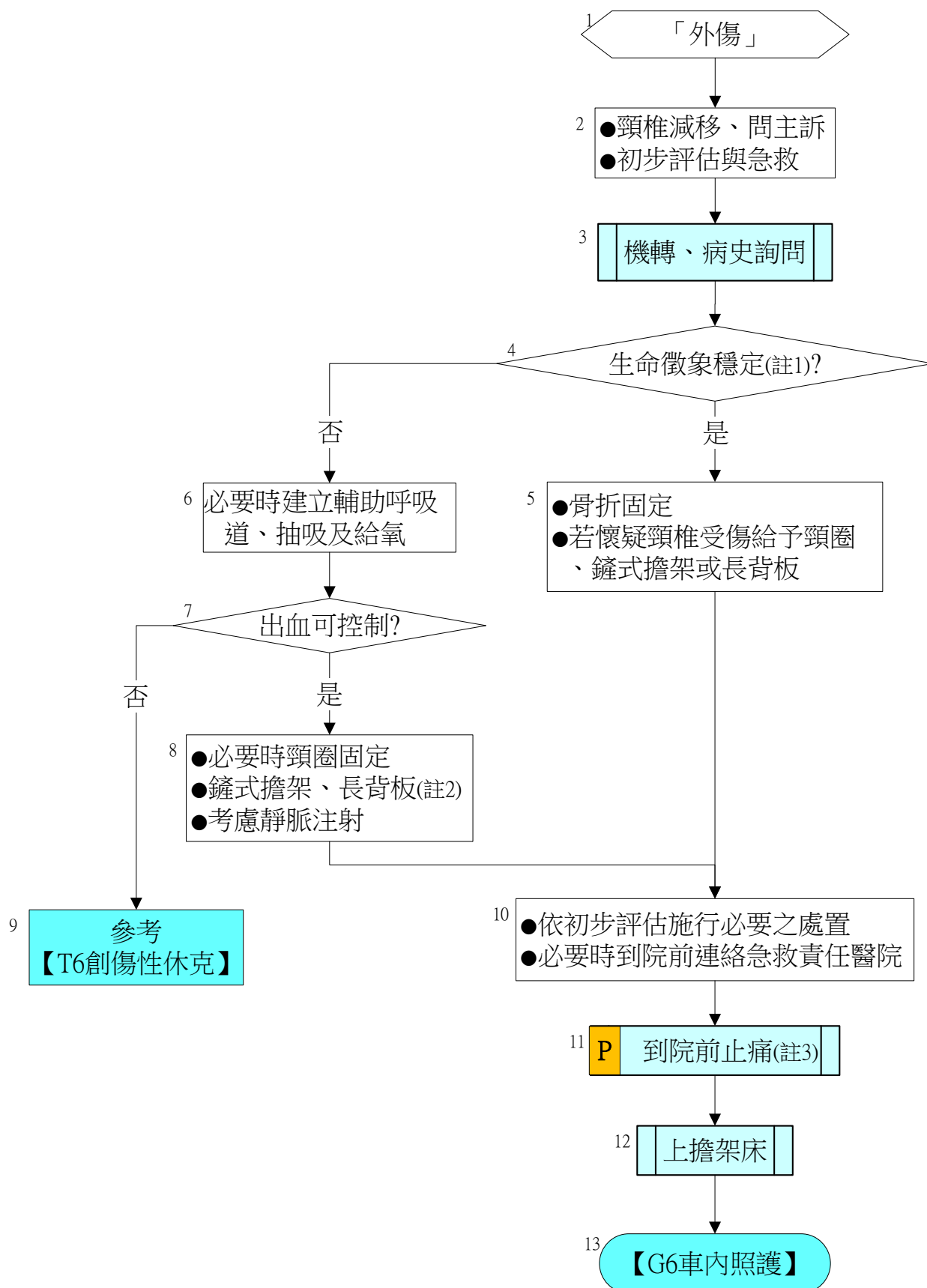


T7 壓砸傷

程 序



要 旨

- 一、傷患因肢體被倒塌建物或車輛擠壓受困時，可能產生壓砸傷症候群，急性症狀包括包括低血容性休克、高血鉀導致心律不整、橫紋肌溶解導致急性腎衰竭與腔室症候群等。
- 二、院前治療原則以大量輸液維持尿流量並將代謝廢物排出為主，高血鉀的預防與治療為輔。
- 三、脫困與處置過程中除了治療遭壓砸傷，仍需要同時評估其他伴隨傷害，例如大出血與低體溫

註 解

註1>

成人可以快速給予0.9%NaCl 生理食鹽水輸注1000ml，之後再次諮詢醫療指導醫師。若周邊血管建立困難且病人意識不清，經醫療指導醫師同意可使用骨針給予輸液與後續之碳酸氫鈉。

註2>

生理監測重點：

在現場環境許可下提供監測。除了血壓血氧脈搏之外，需注意心電圖是否有高血鉀的表現。常見的徵象包含：高尖T波(peaked T-waves)和 寬QRS波。

註3>

*NaHCO₃(碳酸氫鈉)：

將4支NaHCO₃(碳酸氫鈉)針劑，總量約70meq 加入N/S 500 ml，並於N/S點滴瓶上標記藥名、劑量、**流速(如：4 Amp NaHCO₃ + N/S 500ml全速滴注)**，上述輸液治療係屬現場緊急處置，**僅可以給予一次為限**，並應與到院後急診醫護交接處置流程。

註4>

使用止血帶：

若傷患有肢體嚴重出血的狀況，則可以考慮使用。